

Anexo A — Plantilla de priorización MoSCoW

Equipo: Gutierrez Genesis., Nieves Jimmy Paralelo: B Fecha: 03/Junio/2026

Escriba M (Must), S (Should), C (Could) o W (Won't) en cada celda. Las columnas *Cliente* y *Desarrollador* son la priorización *individual* (Fase 2); la columna *Consenso* es el resultado negociado (Fase 5).

ID	Requisito (resumen)	Esf.	Cliente	Desarroll.	Consenso
RF-01	Registro de pacientes	3	M	M	M
RF-02	Reserva de citas en línea	5	M	M	M
RF-03	Consulta por videollamada	8	M	C	M
RF-04	Pago en línea (tarjeta)	8	M	W	W
RF-05	Receta electrónica firmada	5	S	W	W
RF-06	Historial clínico digital	5	C	C	C
RF-07	Recordatorios de cita	3	S	S	S
RF-08	Panel del médico (agenda)	5	S	M	M
RF-09	Calificación del médico	3	M	C	S
RF-10	Chat asíncrono	5	W	W	W
RF-11	Facturación electrónica	5	C	W	W
RF-12	Reportes de actividad	5	M	W	C
NFR-01	Cifrado / protección de datos	5	C	M	M
NFR-02	Usabilidad (adultos mayores)	3	M	M	M
NFR-03	Latencia videollamada <250 ms	3	W	S	S
NFR-04	Disponibilidad 99,5 %	5	W	C	S
Suma de esfuerzo de los <i>Must</i> (consenso):			pts (debe ser ≤ 30) <u>29</u>		

La nota "analista" no se prioriza por separado: el analista no marca su propia columna porque no defiende intereses; su trabajo se evalúa por la calidad de la mediación y del acta. (El analista sí verifica que la columna "Consenso" respete capacidad y dependencias.)

ID	Puntaje
RF-01	3
RF-02	5
RF-03	8
RF-08	5
NFR-01	5
NFR-02	3
Total	29

El consenso final de los requerimientos clasificados como Must suma 29 puntos de esfuerzo. Este acuerdo respeta el límite de ≤ 30 puntos del Release 1 e incluye todas las dependencias técnicas obligatorias.

Anexo B — Votación ponderada (desempate)

Use esta tabla *solo* para los requisitos que el equipo dejó en disputa ("Should" que compiten por la capacidad restante). Califique cada criterio de **1 a 5** y multiplique por su peso. El de mayor puntaje total entra primero.

Criterios y pesos: Valor de negocio (0,40) · Bajo esfuerzo (0,25) · Bajo riesgo técnico (0,20) · Urgencia/dependencia satisfecha (0,15).

ID	Requisito en disputa	V. negocio (×0,40)	Bajo esf. (×0,25)	Bajo riesgo (×0,20)	Urgencia (×0,15)
RF-09	Calificación del médico	$(5 \times 0,40)$ = 2,0	$(4 \times 0,25)$ = 1,0	$(5 \times 0,20)$ = 1,0	$(3 \times 0,15)$ = 0,45
RF-07	Recordatorios de cita	$(4 \times 0,40)$ = 1,6	$(4 \times 0,25)$ = 1,0	$(4 \times 0,20)$ = 0,8	$(4 \times 0,15)$ = 0,60

ID	Puntaje total ponderado (suma de los cuatro productos)	Orden
RF-09	$2,0 + 1,0 + 1,0 + 0,45 = 4,45$	1
RF-07	$1,6 + 1,0 + 0,8 + 0,60 = 4,00$	2

Anexo C — Acta de negociación

C.1 Conflictos identificados

Registre al menos dos conflictos surgidos durante la negociación.

N°	Descripción del conflicto	Tipo / causa	Roles implicados
1	Videollamada (RF-03) vs. pago en línea (RF-04)	Conflicto de intereses (negocio vs. capacidad)	Cliente vs. Desarrollador
2	Inclusión de la receta electrónica (RF-05)	Conflicto estructural (dependencia)	Cliente vs. Desarrollador / Analista

C.2 Resolución win-win

Explique, para cada conflicto, qué acuerdo alcanzaron y por qué *ambas partes ganan* (no por imposición). Indique qué se cedió y qué se obtuvo a cambio.

Conflicto 1:

Se acordó elegir solo una funcionalidad de alto esfuerzo y riesgo para el Release 1 debido a la restricción inamovible de 30 puntos.
El cliente argumentó que la videollamada (RF-03) es vital para salir al mercado antes que la competencia y ofrecer una ventaja clara.
A cambio, el cliente cedió en posponer el pago en línea (RF-04) para el Release 2, aceptando iniciar operaciones con cobros presenciales.
El desarrollador obtiene un proyecto técnicamente viables y sin riesgos superpuestos.

Conflicto 2:

El cliente priorizó inicialmente las recetas electrónicas (RF-05).
El analista medió revelando que normativamente se requiere firma digital y cifrado obligatorio.
El desarrollador reveló que la integración con el sistema de la farmacia (REST-01) no está lista, haciendo el requisito inviable para el Release 1.
El acuerdo fue clasificar RF-05 como Won't por ahora y mantener las recetas en papel en la clínica. Ambas partes ganan: el cliente no desperdicia puntos de esfuerzo en una función bloqueada, y el desarrollador evita comprometer entregables que no dependen de él.

C.3 Verificación del analista

Marque con ✓ cuando se cumpla.

- ☒ La suma del esfuerzo de los *Must* es ≤ 30 puntos.
- ☒ Todo requisito *Must* tiene sus dependencias marcadas como *Must*.
- ☒ Si se aceptó pago en línea (RF-04), receta electrónica (RF-05) o historial clínico (RF-06), el cifrado (NFR-01) es *Must*.
- ☒ RF-11 (facturación) no es *Must* mientras REST-01 no esté disponible.
- ☒ Cada categoría (M/S/C/W) tiene al menos un requisito (la lista no es solo "Must").

C.4 Reflexión final (mínimo 120 palabras)

¿Qué estrategia de resolución de conflictos predominó y por qué? ¿Qué habría pasado si la dueña de la clínica hubiera impuesto todas sus prioridades sin negociar?

La reflexión final se encuentra en la siguiente hoja.



Firma — Cliente



Firma — Analista



Firma — Desarrollador

C.4 Reflexión Final (mínimo 120 palabras)

Durante la resolución del caso MediCita, la estrategia predominante fue la negociación integrativa de tipo win-win. Esta estrategia fue propiciada por el rol del analista como mediador, logrando que las partes revelaran su información asimétrica (como la salida inminente de la competencia, las leyes de datos y las dependencias de APIs). En vez de un regateo hostil, el equipo empató el valor del negocio (lanzamiento rápido y diferenciado) con la viabilidad tecnológica dictada por el desarrollador.

Si la dueña de la clínica hubiera impuesto sus requisitos sin negociar, se habrían sobrepasado drásticamente los 30 puntos de capacidad. Esto habría provocado retrasos en el Release 1, causando que el producto se lanzara tarde y se perdiera la ventaja frente a la clínica competidora.

Además, sin el análisis de dependencias (como intentar reservar citas sin un panel médico o manejar cobros sin cifrado normativo), la plataforma habría fallado técnicamente o habría incurrido en serios problemas de protección de datos de salud.